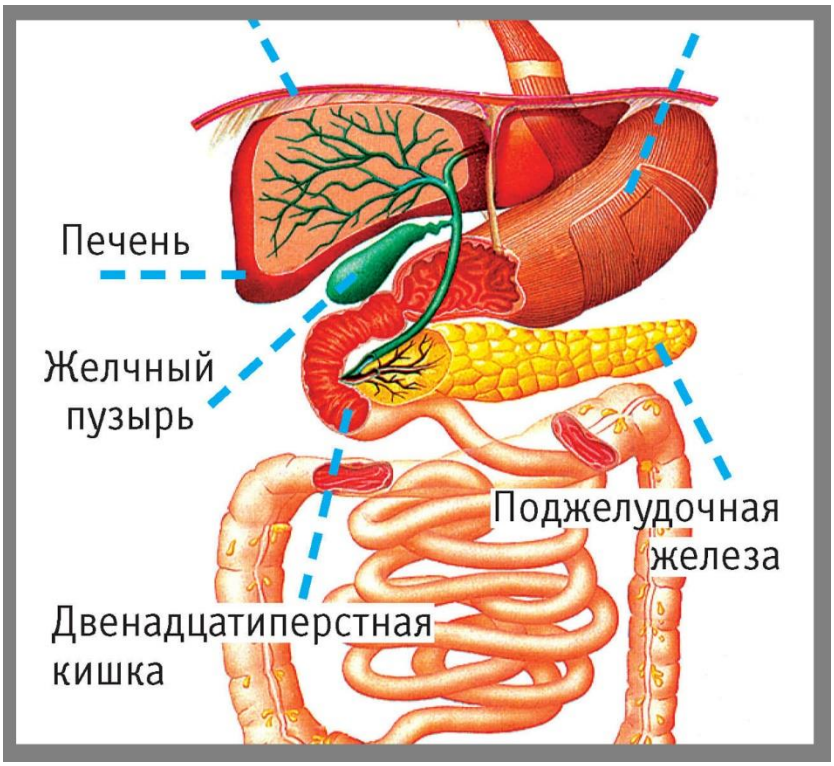
УРОК 5. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ: ДИСКИНЕЗИЯ. ХОЛЕЦИСТИТ. ПОЛИПЫ. ЗАГИБЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. УДАЛЕННЫЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ. СХЕМЫ РАБОТЫ.

Клетки печени производят желчь, которая по желчным протокам скапливается в желчном пузыре (ЖП), из которого желчь вытекает в двенадцатиперстную кишку. К этим протокам также присоединяется проток поджелудочной железы.



Всю ночь печень занимается детоксикаций организма и сбрасывает жирорастворимые метаболиты в желчь, которая копится в жёлчном пузыре. Утром жёлчный пузырь сокращается и выделяет желчь в двенадцатиперстную кишку. Под воздействием желчи улучшается перистальтика кишечника и возникают позывы.

Если утром натощак позывов нет, то это указывает на застой желчи. Иногда позывы в туалет у человека возникают после завтрака, когда человек съел что-либо с жирами.

Как работать с желчеоттоком, мы разбирали на 4 уроке программы ОСНОВЫ НУТРИЦИОЛОГИЯ – I СТУПЕНЬ.

Некоторым людям к работе с улучшением желчоттока нужно относиться как к рутине, как к чистке зубов и делать это на регулярной основе до конца жизни, меняя желчегонный курсы, т.к. желчный пузырь может привыкать в одному курсу.

ВАЖНО! РАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО С ЖЕЛЧНЫМ ПУЗЫРЕМ МОЖНО И НУЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ УЗИ.

КОГДА НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ С ЖЕЛЧЕОТТОКОМ:

- при камнях в желчном пузыре;
- при обострённых заболеваниях желчного пузыря;
- при гипермоторике желчного пузыря.

За сутки печень синтезирует от 500 до 1500 л желчи. Но в самом ЖП находится не более 50 мл. Желчь синтезируется из холестерина, но она состоит не только из холестерина, но также и из воды и желчных кислот. Холестерин взаимодействует с двумя АМК: глицин и таурин, поэтому эти две АМК могут добавляться в протокол по работе с ЖП для того, чтобы нормализовать консистенцию желчи.

ФУНКЦИИ ЖЕЛЧИ:

1. **УСВОЕНИЕ ЖИРОВ И ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ.** С участием желчи происходит эмульгирование и всасывание в кровь жиров и жирорастворимых витаминов (A, D, K, E).

Желчь выделяется из ЖП только на прием пищи с в первую очередь с жирами, затем с белками и лишь потом на углеводы. Поэтому при углеводном питании желчь меняет свою консистеницию, происходит ее застой, что приводит к наршению желчоттока и прочим проблемам и заболеваниям.

2. **ЖЕЛЧЬ НЕЙТРАЛИЗУЕТ СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ.** Желчь – это второе главное вещество после соляной кислоты. Желчь нейтрализует соляную кислоту, которая должна быть только в желудке и не должна попадать в двенадцатиперстную кишку, т.к. в ней кислота будет раздражать слизистую. Поэтому качественный отток желчи также необходим для нейтрализации соляной кислоты в двенадцатиперстной кишенке.

3. **ВЫВЕДЕНИЕ МЕТАБОЛИТОВ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ И МЕТАБОЛИТОВ ГОРМОНОВ.** Желчь участвует в выводе и нейтрализации отработанных гормонов эстрогенов, поэтому при нарушеннуом желчеоттоке возникает СДЭ и заболевания: эндометриоз, кисты, матопатии и пр.

4. **ЖЕЛЧЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ КАЛОВЫХ МАСС И МОТОРИКУ КИШЕЧНИКА.**

5. **АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ.** Желчь нейтрализует паразитов и патогены (это вторая ступень защиты от паразитоза в организме).

5. **АКТИВАЦИЯ ФЕРМЕНТОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.** Желчь участвует в активации ферментов поджелудочной железы и кишечника. Поэтому при проблемах с ферментативной функции поджелудочной железы, обращаем внимание в превую очередь на желчеотток.

СВЯЗЬ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ С ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ

При углеводном питании или питании с нехваткой жиров, меняется состав и качество желчи, она становится густой, также перестает активироваться липаза поджелудочной железы (ПЖ). Липаза ПЖ – это фермент, который играет ключевую роль, в процессе переваривания поступающих с пищей жиров.

При застое желчи всегда будет страдать по цепочке работа поджелудочной железы, т.к. желчь активирует липазу поджелудочной железы. Если питание углеводное, то желчи выделяется мало, желчи не хватает АМК (таурина и глицина), которые есть только в белковой пище, желчь становится густой, ей сложно протекать про протокам и вытекать и ЖП, все это приводит к деформации ЖП, появлению загибов и последствиям нарушенного желчеоттока.

Задержка поступления желчи в двенадцатиперстную кишку приводит к задержке прохождения пищи по кишке и нарушению переваривания жиров. Все это может привести к забросу содержимого двенадцатиперстной кишки в панкреатический проток или задержке поступления ферментов поджелудочной железы из панкреатического протока. Оба этих фактора вызывают повреждение поджелудочной железы с развитием в ней воспалительного процесса – панкреатита.

Кроме того, при нарушении прохождения желчи по общему желчному протоку, давление в нем повышается и желчь, содержащая микроорганизмы и активные вещества, может попадать в панкреатический проток и повреждать ткани поджелудочной железы, так же вызывая ее воспаление.

Поэтому здоровый ЖП и качественный желчеотток – это залог здоровья поджелудочной железы.

ЧТОБЫ ГРАМОТНО ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, НУЖНО ИССЛЕДОВАТЬ:

- симптоматику;
- УЗИ;
- лабораторную диагностику;
- копрограмму,

т.к. на первых этапах нарушения УЗИ может не показать нарушение желчеоттока.

ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ЖЕЛЧЕОТДЕЛЕНИЯ ПО КОПРОГРАММЕ:

- обесцвеченный или светлый кал;
- кислый запах;
- жир нейтральный;
- жирные кислоты;
- мыла.

Эти признаки указывают либо на дефицит желчи, либо на изменения в ее структуре.

	Тип 1 Отдельные твердые комки, как орехи
	Тип 2 В форме колбаски, комковатый
	Тип 3 В форме колбаски, с ребристой поверхностью
	Тип 4 В форме колбаски или змеи, гладкий и мягкий
	Тип 5 Мягкие маленькие шарики с ровными краями
	Тип 6 Рыхлые частицы с неровными краями, кашицеобразный стул
	Тип 7 Водянистый, без твердых частиц

ОЦЕНКА КАЛА ПО БРИСТОЛЬСКОЙ ШКАЛЕ:

- тип 1 и 2 указывает на нарушение желчеотделения или низкую кислотность желудочного сока;
- тип 3 и 4 указывает на нормальный отток желчи;
- тип 5-7 указывает на нарушение желчеоотока, проблемы с поджелудочной железой или на гиперотток желчи.

24 ПОСЛЕДСТВИЯ И СИМПТОМОВ НАРУШЕННОГО ЖЕЛЧЕОТТОКА

1. **ЗАПОР ИЛИ НЕ ПОЛНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА.** Все это не нормально, как думают многие и является ГЛАВНЫМ СИМПТОМОМ и ПОСЛЕДСТВИЕМ нарушенного желчеоттока. Если мы игнорируем этот симптом, пьем слабительные и не работаем с причиной запоров, то через некоторое время это может привести к появлению камней в ЖП и операции. Камни в ЖП пузыре не дробятся, они удаляются вместе с пузырем.

Камни в ЖП пузыре никак себя не проявляют, человек очень долго может с ними жить и случайно узнать о них на УЗИ.

2. **ДИАРЕЯ, НЕСФОРМИРОВАННЫЙ СТУЛ ИЛИ ЖИРНЫЙ СТУЛ** – указывает на проблемы с желчным пузырем, которые за собой тянут нарушение ферментативной функции поджелудочной железы.

3. **ГОРЕЧЬ ВО РТУ.**

4. **ТЯЖЕСТЬ В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ ИЛИ БОЛЬ В ЭПИГАСТРИИ** (эпигастрий – это район солнечного сплетения).

5. **ГАЗООБРАЗОВАНИЯ, МЕТЕОРИЗМ, ВЗДУТИЯ.**

6. **ДЖВП** (дискинезия желчевыводящих путей — это нарушение оттока желчи).

7. КАМНИ И ПОЛИПЫ В ЖП, БИЛИАРНЫЕ СЛАДЖИ (густая желчь) и ВЗВЕСИ.

8. ХОЛЕЦЕСТИТ – ВОСПАЛЕНИЕ ЖП.

9. **СУХОСТЬ КОЖИ.** При нарушенном желчеоттоке начинают плохо усваиваться жиры и жирорастворимые витамины A, D, E, K. Витамин E отвечает за увлажнённость нашей кожи.

10. **ПАРАЗИТОЗ.** Желчь является обезвреживающим средством, способным убивать паразитов. Но если меняется PH желчи, вследствие нарушения кислотно-щелочного баланса в питании, то эта способность утрачивается, иногда паразиты начинают жить в желчных протоках.

11. ТОКСИКОЗ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РВОТА ЖЕЛЧЬЮ ПО УТРАМ.

12. МИГРЕНИ И ГОЛОВНЫЕ БОЛИ во время которых тошнит или рвет желчью.

13. УКАЧИВАНИЕ В МАШИНЕ, тоже является последствием нарушенного желчеоттока.

14. **ТОШНОТА НА ПРИЕМ ЖИРОВ ИЛИ ОТРЫЖКА** после жирной еды с привкусом этой еды.

15. ПОВЫШЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ.

16. СИНДРОМ ЭСТРОГЕН ДОМИНИРОВАНИЯ.

17. ПИГМЕНТАЦИЯ ПОСЛЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.

18. ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ КЕРАТОЗ.

19. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.

20. ВЫСЫПАНИЯ ОКОЛО УШЕЙ, ВИСКОВ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ШЕИ.

21. БЕССОНИЦА (в период с 1 до 3 часов утра активно работает печень).

22. ПОСТОЯННОЕ ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ.

23. **ЧУВСТВО РАЗДРАЖЕНИЯ И АГРЕССИЯ** (желчный человек).

24. **ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЗ-ЗА ДЖВП:** СИБР, кандидоз, цистит, геморрой, варикоз, экзема, дерматит, остеопороз).

ПРИЧИНЫ НАРУШЕННОГО ЖЕЛЧЕОТТОКА (ДЖВП):

1. Нарушения в питьевом режиме, особенно утром;
2. Высокая токсическая нагрузка на печень;
3. Дефицит АМК (глицина и таурина), витаминов и минералов;
4. Не высокая двигательная активность, т.к. моторика ЖП напрямую связана с физической активностью;
5. Дефицит клетчатки (зелень и овощи) в рационе;
6. Избыток сахар, рафинированных углеводов и трансжиров (меняется консистенция желчи, что приводит к ее застою и деформации ЖП;
7. Низкожировое питание;
8. Прием КОК;
9. Заболевания щитовидной железы;
10. Ошибки в питании (4 урок программы ОН-I ступень).

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ.

- изменения в биохимии крови: рост АСТ и АЛТ;
- повышение общего билирубина, щелочной фосфатазы и ГГТ;
- повышение СОЭ и эозинофилов (не всегда).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Одним из главных компоненов желчи являются холестерин и желчные кислоты.

Желчные кислоты расщепляют сложные жиры из пищи. Это природный детергент – моющее вещество (итскуственный детергент – это мыло и стиральные порошок).

Желчь состоит из:

- воды;
- желчных кислот;
- лецитина;
- холестерина;
- билирубина (пигмент);
- белков;
- электролитов (калия, натрия, кальция, хлора).

Исходя из состава желчи, можно сделать вывод о крайне необходимых веществах для ее образования.

1. ВОДА.

При нарушенном желчеоттоке нужно пить не менее 2-х литров воды в сутки 38-40 градусов. До завтрака нужно выпивать 2 стакана тело-горячей воды (можно с лимоно и медом).

2. ЖИРЫ.

Желчь копится в желчном пузыре до поступления жирной или белковой пищи. Жиры необходимы для оттока желчи и для ее консистенции.

Для ЖП особенно полезны:

- **МСТ МАСЛО** (среднецепочечная жирная кислота из кокосового масла. Сразу поступает в печень, а не откладывается в жировой ткани);
- **Масло криля** (мелкая креветка или рачки), содержит омега 3. Биодоступность данного масла в 10-15 раз выше по сравнению с другими маслами (она на 62,8% усваивается организмом, в отличие от других масел с омега 3). Это эффективный источник жирных кислот Омега-3 с содержанием натурального (не обогащенного) астаксантина – мощного антиоксиданта для замедления старения организма.

3. БЕЛОК И РАБОТА С ЕГО УСВОЕНИЕМ.

4. **КЛЕТЧАТКА:** зелень, овощи, фрукты, ягоды, редис, свекла, черная редька, морковь, все виды капусты, домашнаяя квашенная капсута, сельдерей, спаржа, огурцы и пр.

5. ИМБИРНЫЙ ЧАЙ И ЧАЙ ИЗ ОДУВАНЧИКА.

6. ТРЕХ ИЛИ ЧЕТЫРЕХ РАЗОВЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ С ЖИРАМИ И БЕЛКАМИ.

7. **УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩИ В РАССЛАБЛЕННОМ СОСТОЯНИИ** (стресс приводит к спазмам желчного пузыря, что приводит к блокированию оттока желчи)

НУТРИЦЕВТИКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЧЕОТДЕЛЕНИЯ

ТАУРИН, ГЛИЦИН, МЕТЕОНИН – это аминокислоты, кот орые помогают регулировать синтез желчных кислот для расщепления жиров. Они помогают выводить печени токсины, повышают растворимость и вывод холестерина из ЖП.

NAC – это серосодержащая мощная аминокислота, которая повышает уровень глутатиона, но если есть паразитарная или грибковая нагрузка, то лучшее воздержаться от приема этой кислоты.

(их нужно принимать все вместе, в комплексе).

ФОСФОЛИПИДЫ И ИХ ПРЕКУРСОРЫ

ХОЛИН И ИНОЗИТОЛ – это витаминные соединения, которые являбтся важнейшими компонентами всех клеточных мембран. Они необходимы для метаболизма жирных кислот.

ЛЕЦИТИН – это вещество, которое производится в печени из холина.Также содержит инозитол, жирные кислоты и фосфатидилхолин. Эмульгирует жиры и участвует в переработке жирорастворимых витаминов.

ФОСФАТИДИЛХОЛИН – молекула, которая образуется из лецитина, состоит из холина, фосфорной кислоты и углеводородов. Это основной компонент мембран клеток печени, а также основной компонент желчи. Поддерживает нормальный уровень холестерина в крови.

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ НИХ, НЕ ВСЕ СРАЗУ!

Нет добавок, которые бы подошли все без исключения. Если вам не подошел лецитин, то можно поробовать фосфатидилхолин.

МАГНИЙ – это базовая добавка для улучшения оттока желчи. С участием магния происходит активнеое сокращение стенок ЖП с одновременным расслаблентием сфинктера, в результате чего происходит выход желчи в кишку.

Магний стоит на первом месте в работе с запорами. Магний продается в капсулах, а также в виде воды Донат Магния.

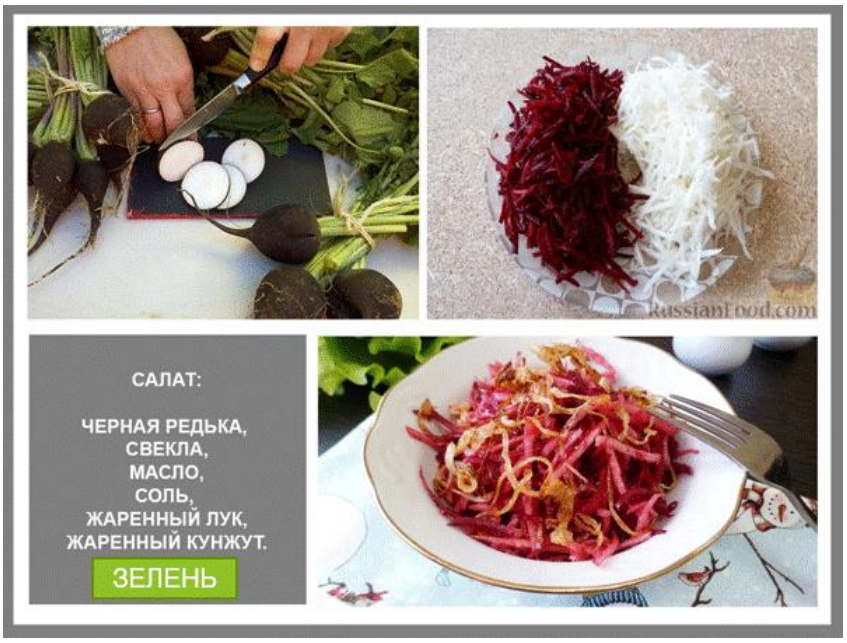
Некоторые исследователи считают, что для работы с ЖП лучше всего подходит цитратная форма магния.

ПЛОДЫ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВЫРАБОТКИ ЖЕЛЧИ

ЧЕРНАЯ РЕДЬКА – содержит вещество raphanine, которое является антисептиком, также помимо усиления желчеоттока, поэтому редька способна растворять камни в желчном и мочевом пузыре.

СВЕКЛА – богата витамином В4 и флавоноидами, которые расслабляют желчевыводящие пути и улучшают отток желчи.

Эти овощи подходят при камнях в ЖП и при удаленном ЖП.



ТРАВЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ОТТОК ЖЕЛЧИ

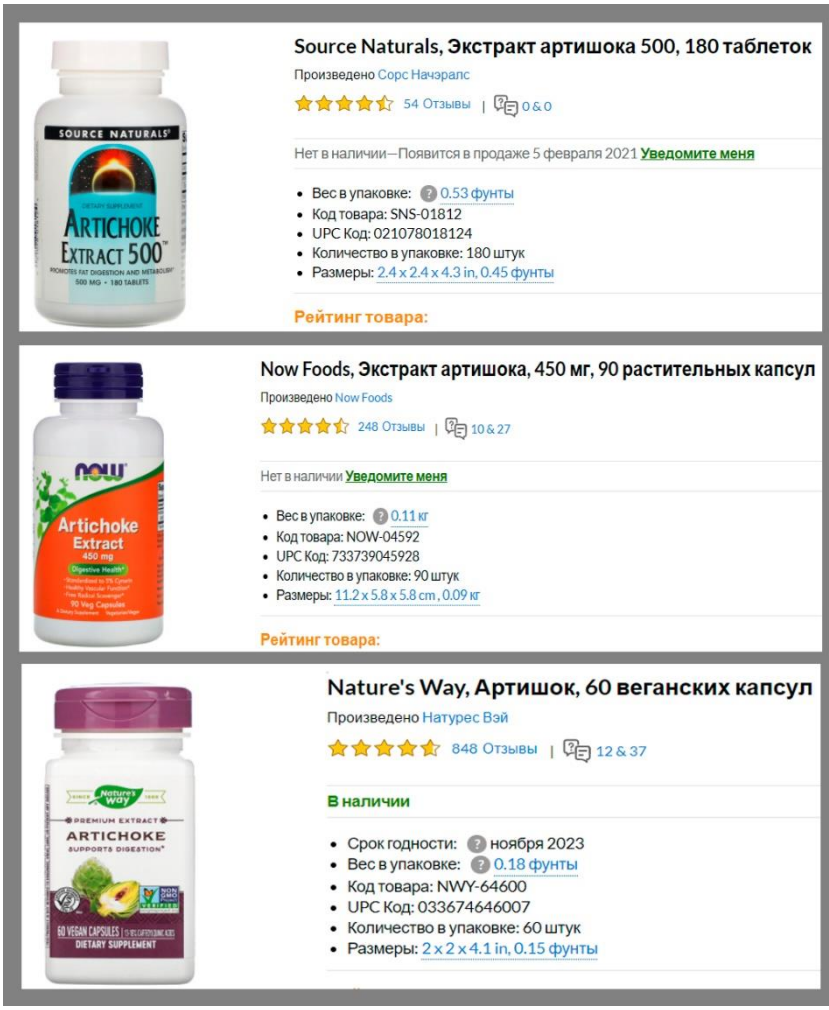
РАСТОРОПША (ЧЕРТОПОЛОХ) ИЛИ СИЛИМАРИН - одно из лучших средств, в том числе и для печени. Состоит из 3-х мощнейших флавоноидов: силибн, силидианин и силикристин, которые защищает печень и ЖП.

АРТИШОК – содердин кофеилхинную кислот, которая стимулирет синтез желчи, улучшает кровообращение в печени и увеличивает защитные ЛПВП.

ОДУВАНЧИК, ИМБИРЬ, ЛОПУХ, МЯТА, ЧИСТОТЕЛ, АЛОЭ ВЕРА.

ВНИМАНИЕ: ПРИ КАМНЯХ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ, ТРАВЫ МОЖНО ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ.

ДАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИНИМАЕМ НЕ ВСЕ СРАЗУ, А ТЕСТИРУЕМ ПО ОДНОМУ!



КАК ПРИНИМАТЬ?

Выбирайте артишок дозировкой от 300 до 500 мг.

Принимать по 1-2 таблетки 1 раз в день до еды или во время приема пищи.

Лучшее время приема и дозировка ВСЕГДА УКАЗАНЫ производителем на упаковке.

Артишок принимается курсами по 2-3 недели, затем делается перерыв и курс повторяется.

ВАЖНО!
(это касается всех желчегонных)

Если стул стал жидким или несформированным, то уменьшайте дозировку артишока, трав или других желчегонных средств!

КАК ПРИНИМАТЬ?

Выбирайте хофитол в дозировке 200 мг.

Хофитол принимается до еды по 2 таблетки - 3 раза в день.

Курс 2-3 недели, затем перерыв 2-3 неделии снова курс.

Во время приема стул может стать темно-коричневым, это нормально.

Если стул стал жидкий, то уберите на несколько дней хофитол, затем принимайте по 1 таблетки 3 раза в день.

Прием магния и трав одновременно может вызвать диарею.

Травами нужно дополнять нутрицевтики, если запоры при их приеме остались.

ПОЛИПЫ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

Полип в ЖП – доброкачественное новообразование в ЖП, которое может перерасти в злокачественное образование.

Полипы бывают одиночные (1-2 см) на ножке и без, как родинки и множественные (сетка наростов полипов внутри или снаружи ЖП). На УЗИ очень хорошо видны полипы.

От 10 до 30 % полипов могут стать злокачественными.

Холестериновые полипы являются самыми распространенными, и лучше всего поддаются консервативной терапии, в отличие от воспалительных полипов, которые могут перерасти в злокачественные.

ПРИЧИНЫ

- воспаление слизистой ЖП из-за сгущения желчи и ее неправильной консистенции;
- инсулинорезистентность и повышение IGF-1 (соматомедина);
- вирусная или бактериальная инфекция;
- нарушения обмена холестерина;
- дефицит витаминов группы В и йода;
- антибиотики и препараты с воздействием на печень;
- кофе в избытке (от 1 чашки в день);
- диеты, рацион с дефицитов жиров, несбалансированное питание;
- заболевания печени;
- воспаление ЖП (холецистит);
- паразитоз;
- регулярное употребление алкоголя;
- прием КОК.

ДИАГНОСТИКА ПОЛИПОЗА

УЗИ печени и ЖП – образования округлой формы, которое не имеет акустической тени.

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОВ

1. Полноценное 3-4 разовое питание без молока, глютена и избытка быстрых углеводов;
2. Работа с желчеоттоком;
3. Работа с причиной образования полипа.

Полипы могут уменьшится и исчезнуть или вырасти новые, а также существующие могут перерасти в злокачественные.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОВ

При хирургическом вмешательстве полипы не удаляются, удаляется полностью желчный пузырь.

Хирургическое лечение – удаление ЖП через проколы в брюшной области, если:

- размер полипа составляет 1 см и больше;
- идет параллельное воспаление ЖП;
- стремительный рост нароста;
- многочисленность полипов;
- высокий риск озлокачествления новообразований.

КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

Желчнокаменная болезнь – это заболевание обмена веществ, которое характеризуется образованием камней в печени и желчном пузыре.

Предвестником образования камней в ЖП является взвесь или билиарный сладж (густая желчь).

Уже на этом этапе нужно работать с питанием, перейти на полноценное безмолочное и безглютеновое питание и начать работать с желчеоттоком.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАМНЕЙ В ЖП ТАКИЕ ЖЕ, КАК И ПРИЧИНЫ НАРУШЕННОГО ЖЕЛЧЕОТТОКА.

РАСТВОРЯТЬ КАМНИ МОЖНО, ЕСЛИ:

- размер камней не более 1 см;
- нет признаков острого воспаления ЖП и печени;
- нет каменей в желчных протоках;
- камни занимают менее половины объема ЖП;
- нет ожирения тяжёлой степени;
- есть динамика растворения камней в течение года.

СХЕМА РАБОТЫ С КАМНЯМИ В ЖП (все препараты назначаются вместе в дозировках, указанных на препарате или в анотации):

1. Яблочный уксус для нормализации кислотности в желудке.
2. Ферменты для пищеварения растительного происхождения в каждый основной прием пищи.
3. АМК (таурин, глицин, ацитилцистеин, глутамин) для пронимаемости мембран компонентов желчи.
4. Лецитин и фосфатидилхолин для усвоения жиров.

5. Уродезоксихолиевая кислота (препараты «Урсофальк» или «Урсосан» аптечный препарат) – разовый прием перед сном для вывода холестерина из камней и их разрушения.

6. Лист Чанка Пьедра («камнеломка») – главная добавка для расстворения камней, способствует перевариванию жиров, выводу токсинов из печени, дробит камни в ЖП И ПОЧКАХ.

ПРИ РАБОТЕ С КАМНЯМИ НЕЛЬЯ ПРИМЕНЯТЬ ЖЕЛЧЕГОННЫЕ ТРАВЫ И ДОБАВКИ (одуванчик, артишок, розмарин, лопух и другие).

Перед применением схема проконсультируйтесь с врачом, т.к. могут быть исключения. Самостоятельно назначать себе данную схему нельзя.

Дробление камней занимает от года до двух лет.

ЕСЛИ КАМНИ ЗАНИМАЮТ БОЛЬШЕ 50% ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ТО ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ УДАЛЯЕТСЯ.

УДАЛЕННЫЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ (ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ)

Удаление ЖП не решает проблему густой желчи и даже при удалённом ЖП могут остаться запоры. Поэтому выстроить свое питание и закрыть дефициты, приведшие к удалению ЖП нужно обязательно.

При запорах и удаленном ЖП можно и нужно проходить желчегонный курсы (от простых до более сложных).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЖП

- диарея или частый стул при избытке желчи;
- запор при дефиците желчи;
- СРК и СДК;
- дисбактериоз;
- дефицит витаминов A, D, E, K (зрение, иммунитет, остеопороз, качество кожи).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НУТРИЦЕВТИКАМ ПРИ УДАЛЕННОМ ЖП

- лецитин и фосфатидилхолин (с каждым приемом пищи для улучшения консистенции желчи);

- ферменты с липазой, которая помогает расщеплению жиров (при употреблении жирной пищи);

- артишок или силимарин (при запорах);

- куркумин (снимает воспаление, принимать строго с жирной пищей, нельзя принимать при анемии).

ДАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТСЯ ВСЕ ВМЕСТЕ В КОМПЛЕКСЕ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ УДАЛЕННОМ ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

После холецистэктомии ЖКТ необходимо 2-3 месяца, чтобы адаптироваться к постоянному истечению желчи в двенадцатиперстную кишку и это время нередко сопровождается следующими симптомами: боли в желудке из-за рефлюкса, диарея или запор, повышенное вздутие, неприятные ощущения в области поджелудочной железы (она часто воспаляется).

Специальное диеты при удаленном ЖП не существует. В ближайший послеоперационный период рекомендуется есть дробно (4-6 раз в день), небольшими порциями, пищу без жаренного, острого, сладкого, кислого и чрезмерно жирного. Еда и напитки должны быть теплыми. Ничего холодного нельзя.

В каждом приеме пищи должны содержаться жиры.

Через 2 месяца можно перейти на 3-4 разовое питание без перекусов.

После холецистэктомии хуже усваиваются жиры и жирорастворимые витамины. Обязательно нужно отслеживать уровень витамина D.

При ослабленном пищеварении назначаются растительные ферменты, желчные кислоты и жирорастворимые витамины.

Также можно назначить самостоятельно пробиотики, т.к. после операции меняется состав микрофлоры кишечника.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Кому нельзя проходить желчегонные курсы?
2. Какие функции у желчи?
3. Расскажите, как нарушение желчеоттока влияет на воспаление поджелудочной железы?
4. Как грамотно оценить состояние ЖП?
5. Расскажите о признаках нарушения желчеотделения в копрограмме?
6. Перечислите последствия нарушения желчеоттока?
7. Расскажите о причинах нарушенного желчеоттока?
8. Как меняются печеночные пробы при нарушении желчеоттока?
9. Какие рекомендации по питания вы дадите человеку с нарушенным желчеоттоком?
10. Что такое МСТ масло?
11. Чем масло криля отличается от других видов масел, содержащих омега 3?
12. Какие нутрицевтики можно пропить для восстановления желчеоттока?
13. Какие плоды стимулируют выработку желчи?
14. Что такое полип в ЖП?
15. Какие полипы бывают?
16. Какие причины полипоза?
17. Как диагностирую полипы?
18. Как работать с полипами?
19. В каких случая полипы удаляются хирургически? Как это происходит?
20. В чем причина образования камней в ЖП?
21. Можно ли растворить камни в ЖП?
22. Расскажите все, что вы знаете о растворения камней в ЖП?
23. Что происходит в первые 2-3 месяца после холецистэктомии?
24. Какие рекомендации по питанию вы дадите после холецистэктомии и через 3 месяца после нее?
25. Нужно ли работать с желчеоттоком после холецистэктомии?